

جوستاف روسي انترناسيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : مرفت محمد عبدالرحمن محمد

المحافظة : القاهرة

الحى / المدينة : المعادى

العنوان : 28 ش حسن رضوان

رقم البطاقة : 27307310102024 رقم التليفون : 01144993255

تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 31-07-1973 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) المقرر بما فيه
التوقيع: (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه

التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض بالصيغه [11127]

**قسم العلاج :
الاورام**

----- التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: _____ إلتوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناقشة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / د ----- / د ----- / د. | ----- / د. |

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جـهـة العـلاج :

ملاحظات : ---

قسم : --

نفقات :

ختم

شعار الجمهورية

مدیر عام

مديرية الشئون الصحية

رئيس

المجلس الطبي المتخصص

Name: مرفت محمد عبدالرحمن محمد
National ID: 27307310102024



تقرير طبي

السيد

تحية طبية وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ ومساءة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ ومساءة الدخول :
--:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest and abdomen

الوقت :

--:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



مرفق
محمد عبدالرحمن محمد عيسى
١٨ ش حسن رضوان
المعادي - القاهرة

٢٧٣٠٧٣١٠١٠٢٠٢٤
١٩٧٣/٠٧/٢٨

JL4523198

٢٠٢٤ / ١٨ / ٥

١١٤٤٩٩٣٥٥٥
١١٤١٣٦١٢٢٢
قامو
"عيسى"

٢٠٢٤

٢٠٢٢/٠٧ ٢٧٣٠٧٣١٠١٠٢٠٢٤
حاصله على دبلوم تجاره



انثى
مسلمة
متزوجة
محمد محمود احمد عربى
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٧/١٩



١





رسوم الاستعلام 20 جنية

جيهه الاصدار : فرع القاهرة

تاريخ الاصدار : 2026-8-5

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع بالخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (د) مرفت محمد عبدالرحمن محمد بطاقة رقم 27 07310102024
تليفون رقم : 01144993255

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل



تاريخ العبارة : 2026-8-5

المرفق المختص

مود عبدالله

اقادة مركز نظم المعلومات

يعتد

مسلسل 2026-8-5



د مرفت

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغير حاله المواطن من قبل الهيئة " مية للتأمينات الاجتماعية او وزارة التضامن الاجتماعي او وزارة التربية والتعليم

الادارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقمي

اسم المريض بالإنجليزية: Mervat Mohamed Abdalrahman Mohamed	كود المريض: 97859
تاريخ التقرير: 2026/08/05 12:06:19 PM	السن: ٥٣ سنة

Women's Health Outreach Program

Name: Mervat Mohamed Abd El Rahman

Date: 5-8-2026

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 53 years old female complaints of right breast lump

Right breast:

- Homogenous fatty breast (ACR density A).
- The right breast shows two spiculated dense mass lesions with they are located in the upper outer quadrant
- **Ultrasound** revealed two deeply hypoechoic, antiparallel, irregular mass lesions, the index mass lesion measures about 13 x 12 mm along the main dimensions, and about 3 mm beneath skin surface, and the other is located opposite 12 :00 clock measures 11 x 14 mm along the main dimensions and about 3 mm, the distance between the both lesions is about 4.5 cm
- Normal nipple/areolar complex.
- No features of suspicious looking lymph nodes on ultrasound basis

Left breast:

- Homogenous fatty breast (ACR density A).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Multiple small dispersed subcentimetric thin-walled anechoic cysts.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5):** Right UOQ bifocal malignant looking mass lesions, as described above for histopathological correlation
- **Left breast (BIRADS 2):** Normal findings.

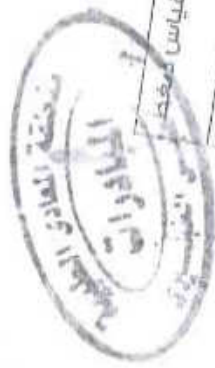
*Much obliged,
Dr. Hekmat Samir, MD*

١٠٠ مليون
صححة

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

محمد عبد الرحمن محمد التاريخي
٢٠٠٧ ٣ ١٠ ٢٠٢٦
١١ ٢٢ ٩٩ ٣ ٢٥٥

توعية
لتوعية والفحص الإكلينيكي



الطول	مؤشر كتلة الجسم	قياس السكر العشوائي	قياس ضغط الدم

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

مرفق
محمد عبدالرحمن محمد عيسى
١٨ ش حسن رضوان
المعادي - القاهرة

٢٧٣٠٧٣١٠١٠٢٠٢٤

JL4523198

لفحص الذاتي شهريا

توفمبر 2025	
فبراير 2026	
مايو 2026	
أغسطس 2026	
نوفمبر 2026	
فبراير 2027	
مايو 2027	
أغسطس 2027	



السلطة المصرية
للصحة

صحة ١٠٠ مليون

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

محمدي عبد الرحمن محمدي التاريفي ٨١/٨/٢٠٢٤
٢٠٢٤ ١٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٢٤ ١٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٢٤ ١٠٠٠٠٠٠٠

فئة بالتوعية
فئة بالتوعية والإفحص الإكلينيكي



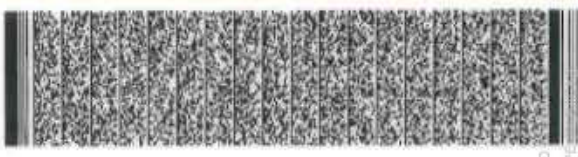
الطول	مؤشر كتلة	قياس السكر	قياس ضغط

جد الفحص الذاتي شهريا

نوفمبر 2025	2
فبراير 2026	2
مايو 2026	2
أغسطس 2026	20
نوفمبر 2026	20
فبراير 2027	20
مايو 2027	20
أغسطس 2027	20



٢٠٢٢/٠٧ ٢٧٣.٧٣١.١٠٢.٢٤
حاصله على دبلوم تجارة
انثى مسلمة
محمد محمود احمد عربى
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٧/١٩



ID 13717

Patient Name	مريض محمد عبدالرحمن	Case No.	346832
Sex/Age	Female 53 Y	Patient No.	25647
Registered Date	08/8/2026 04:02:04 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	06/9/2026 12:30:17 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	17/9/2026 12:50:04 PM	Pathology No.	2502/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast 12 O'clock mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 10/08/2026, at 12:20 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.7 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 2)
- DCIS: Solid pattern with comedo type necrosis.
- Angioinvasion: Absent
- Perineural invasion: Absent

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in less than 10% of tumor cells (score 0+).
- Ki67%: 15%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
- Ductal carcinoma in situ: Solid pattern with comedo type necrosis.
- IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).



Patient Name	مرىف محمد عبدالرحمن	Case No.	346832
Sex/Age	Female 53 Y	Patient No.	25647
Registered Date	08/8/2026 04:02:04 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	06/9/2026 12:30:17 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	17/9/2026 12:50:04 PM	Pathology No.	2502/26

- Her2: Ultra-low (score 0+).
- Ki67%: 15%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonain, MD.

Dr: Doaa Ali.



خريطة رقم (4) - الطور الثاني - مبنى رقم (987) - مركز البحوث الطبية - مصر - القاهرة 3 - مصر
Roem No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Nisar El Qaitema - Cairo, Egypt

اسم المريض بالإنجليزية: Mervat Mohamed Abd El Rahman Mohamed	كود المريض: 97859
تاريخ الفحص: 2026/08/05 12:06:19 PM	السن: 53 سنة

Women's Health Outreach Program

Name: Mervat Mohamed Abd El Rahman

Date: 5-8-2026

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 53 years old female complaints of right breast lump

Right breast:

- Homogenous fatty breast (ACR density A).
- The right breast shows two spiculated dense mass lesions with they are located in the upper outer quadrant
- Ultrasound revealed two deeply hypoechoic, antiparallel , irregular mass lesions , the index mass lesion measures about 13 x 12 mm along the main dimensions, and about 3 mm beneath skin surface , and the other is located opposite 12 :00 clock measures 11 x 14 mm along the main dimensions and about 3 mm , the distance between the both lesions is about 4.5 cm
- Normal nipple/areolar complex.
- No features of suspicious looking lymph nodes on ultrasound basis

Left breast:

- Homogenous fatty breast (ACR density A).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Multiple small dispersed subcentimetric thin-walled anechoic cysts.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Right breast (BIRADS 5): Right UOQ bifocal malignant looking mass lesions , as described above for histopathological correlation
- Left breast (BIRADS 2): Normal findings .

Much obliged,
Dr. Mervat Samir, MD

د. أحمد صبرى راجح

أ.د. أحمد صبرى راجح

أ.د. خالد أحمد لحوظ

د. كريم خالد لحوظ

للأشعة
التحاليل الطبية



Patient Name: حنان عبدالله عبدالله عبد الله	Study Date: 19/04/2026
PROF DR.: عمر السباح	Patient ID: 656524

MRI EXAMINATION OF NECK WITH CONTRAST REVEALS:

Technique: multiple sequences were done

**Status: known case of thyroidectomy for cancer thyroid & cancer breast:

- A well-defined rather oval shape soft tissue mass lesion seen centered upon left parapharyngeal space/carotid space region measuring about 39x27x24 mm anterior to the carotid vessels with no vascular invasion, no splaying of the carotid vessels.
- Such mass showing the following relations;
 - o **Anteriorly:** abutting the posterior aspect of the left medial pterygoid muscle with no invasion.
 - o **Posteriorly:** has minimal tongue like extension to the carotid space, abutting & separable from the pre-vertebral muscles.
 - o **Medially:** Compressing the oropharynx causing its mild narrowing.
 - o **Laterally:** it has tongue like projection abutting & inseparable from the deep part of the parotid gland.
- **No invasion of surrounding structures.**
- This lesions displays iso signal intensity at T1w, bright signal intensity at T2w & STIR with numerous areas of low signal septations, heterogeneous avid post contrast enhancement, no diffusion restriction at DWI/ADC map.
- No evidence of neck fluid collections/abscess cavities.
- Normal supra, glottic & infra-glottic regions with no current mass lesions.
- Normal true & false vocal cords with preserved para-laryngeal fat.
- Normal shape and signal intensities of the parotids and right sub mandibular glands.
- Normal signal voids neck vessels.
- Small bilateral deep cervical and submandibular subcentimetric lymph nodes of benign nature (reactionary/inflammatory).
- **Effusion of the left mastoid air cells.**

Opinion:

- o Left parapharyngeal/carotid space mass lesion with no invasion of the surrounding structures ----suggesting benign salivary gland tumor (pleomorphic adenoma) VS schwannoma.

Thanks for reference,
Prof.Dr./Ahmad Sabry Ragheb
Dr. Rasha Osama, MD

الأشعة
التحليل الطبية



Patient Name: حنان عبدالله عبدالله Patient ID: 766688	Study Date: 25/04/2026 Patient ID: 766688
---	--

NECK ULTRASONOGRAPHY REVEALS:

Status: History of total thyroidectomy.

- Clear thyroid operative bed with no residual or recurrent masses.
- Normal vocal cords.
- Normal both submandibular glands with no focal masses.
- Normal neck vascular structures.
- Well-defined hypoechoic soft tissue lesion noted at the LT parapharyngeal space/carotid space region measuring about 39x27x24 mm anterior to the carotid vessels... Benign salivary gland tumor (pleomorphic adenoma) VS schwannoma.
- Few enlarged cervical L.Ns seen at RT submental, both submandibular & upper deep cervical regions about 4-12 mm, all display preserved central fatty hilum...
- Reactionary L.Ns.

Thanks for references
Yours

Prof. DR: Khaled Lakouz
Dr. Mohamed G. Menshawy, MD

أ.د. خالد أحمد لكوظ
أ.د. أحمد صبري رافع
أ.د. خالد لكوظ
أ.د. محمد هشام صالح
أ.د. ناصر محمد إبراهيم

الأشعة
التحاليل الطبية



Patient Name: حنان عبدالله عبدالله	Study Date: 29/01/2026
PROF DR.: اشراف شوقي	Patient ID: 766688

MULTISLICE CT BRAIN AND NECK ANGIOGRAPHY WITH MIP AND VOLUME RENDERING REVEAL:

• Status: known case of total thyroidectomy for thyroid cancer:

- There is a mass in the left side of the neck measuring 32x25 mm. This mass shows soft tissue density. It is located within left parapharyngeal space and left carotid space, it abuts left pharyngeal wall, left medial pterygoid muscle and left prevertebral muscle with loss of intervening fat planes (no invasion).
- Vascular findings:
 - The mass exhibits faint contrast enhancement. It abuts short segment of left internal carotid artery with no vascular invasion. No splaying of carotid vessels.
 - Normally opacified aortic arch, RT brachiocephalic, LT CCA & LT SCA arteries. No segments of significant stenosis or complete occlusion.
 - Normally opacified, patent lumens of both CCAs. No significant stenosis or occlusion.
 - Normally intensely opacified bilateral ICA & ECA. No vascular occlusion, obstruction, stenosis or AVM.
 - Normal sphenoid portion (M1), insular portion (M2), opercular (M3) portions and (M4) cortical portion of the middle cerebral arteries (MCA).
 - Normal anterior cerebral arteries (ACA) with no vascular occlusion, obstruction, stenosis or AVM.
 - Normal vertebro-basilar arterial circulation with no vascular occlusion, obstruction, stenosis or AVM.

Opinion:

Left neck mass as described....Metastasis Vs Vagal schwannoma are suggested.

Thanks for references
Yours

Prof. Dr: Khaled Lakouz
Dr. Karim Kh. Lakouz MD
Dr. Ahmed El Shalkamy, MSc

ا.د. خالد أحمد لكوز

ا.د. أحمد صبور رائد
ا.د. خالد عبدالحل
د. كريم خالد لكوز
د. محمد هشام صالح

الأشعة
التحليل الطبية



Patient Name: خان عبدالله عبدالله	Study Date: 29/01/2026
PROF DR.: ا.د. خالد لكوز	Patient ID: 766688

MULTISLICE CT BRAIN AND NECK ANGIOGRAPHY WITH MIP AND VOLUME RENDERING REVEAL:

• Status: known case of total thyroidectomy for thyroid cancer:

- There is a mass in the left side of the neck measuring 32x25 mm. This mass shows soft tissue density. It is located within left parapharyngeal space and left carotid space, it abuts left pharyngeal wall, left medial pterygoid muscle and left prevertebral muscle with loss of intervening fat planes (no invasion).
- Vascular findings:
 - The mass exhibits faint contrast enhancement. It abuts short segment of left internal carotid artery with no vascular invasion. No splaying of carotid vessels.
 - Normally opacified aortic arch, RT brachiocephalic, LT CCA & LT SCA arteries. No segments of significant stenosis or complete occlusion.
 - Normally opacified, patent lumens of both CCAs. No significant stenosis or occlusion.
 - Normally intensely opacified bilateral ICA & ECA. No vascular occlusion, obstruction, stenosis or AVM.
 - Normal sphenoid portion (M1), insular portion (M2), opercular (M3) portions and (M4) cortical portion of the middle cerebral arteries (MCA).
 - Normal anterior cerebral arteries (ACA) with no vascular occlusion, obstruction, stenosis or AVM.
 - Normal vertebro-basilar arterial circulation with no vascular occlusion, obstruction, stenosis or AVM.

Opinion:

Left neck mass as described....Metastasis Vs Vagal schwannoma are suggested.

Thanks for references
Yours

Prof. Dr: Khaled Lakouz
Dr. Karim Kh. Lakouz MD
Dr. Ahmed El Shalkany, MSc

حضانة عبد الله عبد الله	Study Date: 19/04/2026
عصر الصباح	Patient ID: 656524

MRI EXAMINATION OF NECK WITH CONTRAST REVEALS:

Technique: multiple sequences were done

****Status: known case of thyroidectomy for cancer thyroid & cancer breast:**

- A well-defined rather oval shape soft tissue mass lesion seen centered upon left parapharyngeal space/carotid space region measuring about 39x27x24 mm anterior to the carotid vessels with no vascular invasion, no splaying of the carotid vessels.
- Such mass showing the following relations ;
 - o **Anteriorly:** abutting the posterior aspect of the left medial pterygoid muscle with no invasion.
 - o **Posteriorly:** has minimal tongue like extension to the carotid space, abutting & separable from the pre-vertebral muscles.
 - o **Medially:** Compressing the oropharynx causing its mild narrowing.
 - o **Laterally:** it has tongue like projection abutting & inseparable from the deep part of the parotid gland.
- **No invasion of surrounding structures.**
- This lesions displays iso signal intensity at T1w, bright signal intensity at T2w & STIR with numerous areas of low signal septations, heterogeneous avid post contrast enhancement, no diffusion restriction at DW/ADC map.
- No evidence of neck fluid collections/abscess cavities.
- Normal supra, glottic & infra-glottic regions with no current mass lesions.
- Normal true & false vocal cords with preserved para-laryngeal fat.
- Normal shape and signal intensities of the parotids and right sub mandibular glands.
- Normal signal voids neck vessels.
- Small bilateral deep cervical and submandibular subcentimetric lymph nodes of benign nature (reactionary/inflammatory).
- **Effusion of the left mastoid air cells.**

Opinion:

- Left parapharyngeal/carotid space mass lesion with no invasion of the surrounding structures---suggesting benign salivary gland tumor (pleomorphic adenoma) VS schwannoma.

Thanks for reference,

**Prof.Dr./Ahmad Sabry Ragheb
Dr. Rasha Osama, MD**

GUSTAVE / ROUSSY

INTERNATIONAL
EST. 1972

Patient Name: Hanan Abd Alliah Abd Alliah Halima	Date : August 30, 2026
Exam : Ultrasound ABDOMEN& PELVIS	

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver:-

- Enlarged (21 cm at Rt MCL) bright homogenous parenchymal echo pattern.
- No IHBRD seen
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder:-

Average size, no stone and no masses. Patent CBD and not dilated.

Spleen:-

- Normal size 11 cm, homogenous texture with no focal lesions

- Kidneys:-

- Both kidneys of normal size, shape, normal echogenicity and well differentiated with good corticomedullary differentiation.

- No stones , no back pressure changes

Para-aortic and pancreatic area: homogenous with no masses or cystic lesions.

Urinary Bladder:-

- Is empty at time of scan.

Uterus and adnexae:-

- Not visualized (surgically removed).

Opinion:

Fatty hepatomegaly for lab and clinical correlation.

Dr. Dina Anter